



# Transtorno Depressivo Maior no Idoso

## Definição

Considerada por muitos como um processo natural do envelhecimento, o que pode inferir em subdiagnóstico.

É uma doença que interfere negativamente na morbidade de doenças físicas como DM, HAS, fraturas.

Utilizam serviços médicos 50 a 100% mais que os não deprimidos, geralmente é um paciente poliqueixoso. Apresentam queixas médicas inespecíficas 3 a 4x mais.

**Há a presença dos sintomas cardinais como humor deprimido e/ou perda de interesse, com prejuízo no seu dia a dia por mais que 14 dias.**

## ▼ Epidemiologia

Depressão no idoso é subdiagnosticada e incorretamente tratada. 76,6% dos idosos não foram perguntados por seus médicos se sentiam tristes ou deprimidos.

Doença psiquiátrica mais comum no idoso com incidência de 2 a 4% em idosos saudáveis, e 10 a 14% em idosos hospitalizados, e 20 a 25% em asilos (geralmente pelo histórico pessoal do idoso).

15 a 30% dos casos não entram na classificação do DSM-V.

Risco de suicídio em idosos é maior.

## ▼ Fator de risco

- Sexo feminino;
- Baixa escolaridade;
- Abuso do álcool;
- Eventos estressantes;

- Mora sozinho;
- Viuvez: especialmente em homens, que sofrem mais com a viuvez;
- Limitações físicas;
- Traumas psicológicos;
- Aposentadoria;
- Síndrome do Ninho Vazio

#### **Doenças físicas** como:

- Doença de Parkinson: além da diminuição da dopamina reduz a serotonina, bem como pelas limitações que a doença causa;
- Artrite Reumatóide;
- Demência Vascular;
- Câncer;
- AVC;
- Alzheimer;
- DM;
- IAM.

#### **Medicamentos** como:

- beta-bloqueador;
- Bloqueadores de canais de cálcio;
- Metildopa;
- IECA;
- Tamoxifeno;
- Corticoesteróides;
- Barbitúricos;
- Progesterona;
- Digoxina;
- L-dopa.

Há um preconceito social em relação aos idosos, chamado de **idadismo**, o que também aumenta o risco.

Além disso, os idosos tem medo da perda da dignidade (ter que depender muito dos filhos, por exemplo), de ser uma sobrecarga para os filhos e institucionalização.

### **Classificação**

- **Depressão Início Tardio:** nunca teve depressão, mas quando ficou idosos, por diversos fatores, desenvolveu. Possui maior grau de apatia, disfunção

cognitiva, com anormalidades no lobo temporal;

- **Depressão de Início Precoce.**

- ▼ **Depressão vascular**

Depressão Vascular por lesões subcorticais decorre de lesões em núcleos da base e lobos frontais.

Ateroesclerose e depressão estão associados no idoso, então quanto maior processo aterosclerótico maior o processo depressivo.

Doença vascular exerce efeito maior na depressão com o aumento da idade. (Mast et al. 2005).

Maior prevalência de depressão na demência Vascular do que no Alzheimer. Maior índice de déficits de função executiva, retardo psicomotor, insatisfação excessiva.

- ▼ **Depressão refratária**

10%, mesmo com tratamento adequado, persistem com depressão. Possui maior relação com atrofia cerebral, alterações na substância branca e cinzenta subcortical.

**Consideramos refratária quando não há resposta a pelo menos dois antidepressivos de grupos diferentes, com doses e tempo adequados.**

### ***Quadro clínico***

- Melancolia e tristeza;
- Anorexia e perda de peso;
- Sintomas psicóticos: especialmente em casos mais graves;
- Hipocondria;
- Agitação psicomotora;
- Ideias de suicídio;
- Desconforto abdominal;
- Falta de energia, fadiga;
- Alterações sexuais;
- Apatia, perda do interesse;
- Pobreza da fala;
- Prejuízo cognitivo/ alteração de memória: podem evoluir para Alzheimer.

- Ansiedade, irritabilidade e insônia;
- Dores difusas;
- Menores sentimentos de culpa;
- Tonturas;

Paciente não melhorou da memória ao tratar para a depressão, pode indicar um distúrbio cognitivo que está causando sintomas depressivos.

### ▼ Suicídio no idoso

Maior risco em homens idosos mas as tentativas são menos frequentes que os jovens.

Taxas de suicídio consumado são maiores nos idosos, comumente com uso de métodos mais letais, por isso, se tiver uma ideação clara devemos internar o paciente.

Fatores de risco:

- Doença mental;
- Doença física;
- Isolamento social e solidão;
- Rede social não estruturada;
- Luto;
- Problemas familiares.

### ▼ Teste de Rastreio

#### ▼ Escala de Yesavage

Score >5 é suspeita de depressão.

|                                                                      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Sente-se satisfeito(a) com a vida?                                   | Sim | Não |
| Interrompeu muitas atividades de seu interesse?                      | Sim | Não |
| Sente que a vida está vazia?                                         | Sim | Não |
| Aborrece-se com frequência?                                          | Sim | Não |
| Sente-se de bem com a vida (de bom humor) a maior parte do tempo?    | Sim | Não |
| Tem medo que algo de ruim lhe aconteça?                              | Sim | Não |
| Sente-se alegre (feliz) a maior parte do tempo?                      | Sim | Não |
| Sente-se desamparado(a) com frequência?                              | Sim | Não |
| Preferir ficar em casa a sair e fazer coisas novas?                  | Sim | Não |
| Acha que tem mais problemas de memória do que a maioria das pessoas? | Sim | Não |
| Acha que é maravilhoso estar vivo(a)?                                | Sim | Não |
| Vale a pena viver como vive agora?                                   | Sim | Não |
| Sente-se cheio(a) de energia?                                        | Sim | Não |
| Acha que a sua situação tem solução?                                 | Sim | Não |
| Acha que a maioria das pessoas está em situação melhor que a sua?    | Sim | Não |

## Diagnóstico

Usamos o **DSM-5**, em que é preciso pelo menos 5 sintomas:

- Sintoma obrigatório: humor depressivo ou marcada diminuição do interesse ou prazer na maioria das atividades ou todas elas;

- Outros sintomas:
  - Emagrecimento sem relação com dietas, ganho de peso significativo ou alterações do apetite;
  - Hipersônia ou insônia;
  - Agitação ou depressão psicomotora;
  - Fadiga ou sensação de perda de energia;
  - Sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada;
  - Indecisão ou dificuldade para se concentrar ou raciocinar;
  - Pensamentos de morte recorrentes ou ideação suicida com ou sem planejamento.
- Sintomas que causam impacto significativo nas diversas esferas, tais como social ou ocupacional;
- Sintomas que não são decorrentes do uso de alguma substância/medicamento ou de outra enfermidade;
- Sintomas não explicados por desordem esquizoafetiva ou psicótica, além de não haver episódio hipomaníaco ou maníaco.

#### ▼ **Depressão subsindrômica**

É uma depressão “mais leve”, com a presença de  $\geq 2$  sintomas depressivos na maior parte do tempo, durante pelo menos 14 dias.

Não preenchem o critério para depressão maior, mas pode preceder o quadro de depressão maior em 3 anos.

Geralmente são pacientes não tristes, mas com desânimo.

#### ▼ **Exames complementares**

Laboratório:

- Hemograma;
- Glicemia jejum;
- Eletrólitos: hiponatremia, hipocalemia podem mimetizar;
- Uréia e creatinina;

- TSH, T4 livre: hipertireoidismo pode ser apático, em que não tem sintomas clássicos e sim apatia, desânimo, cansaço;
- Urina I;
- B12, ácido fólico: deficiência destes podem causar distúrbios cognitivos;
- Testosterona: quadros de hipogonadismo podem simular quadros depressivos.

Tomografia e ressonância de encéfalo pedimos para os pacientes com alterações cognitivas associadas a depressão.

### ***Evolução da doença***

Grande número de pacientes não preenchem os critérios diagnósticos.

Após o tratamento um terço melhora, outro terço tem recaída e o restante não melhora e tem recaída.

A possibilidade de recaída é maior naqueles que demoram a responder, tem ansiedade associada, cursam com evento médico ou social e escore alto.

Obs: é comum também os idosos melhorarem da depressão e por isso pararem de tomar o remédio.

### ***Tratamento***

#### **▼ Medidas não farmacológicas**

- Psicoterapia;
- Exercício físico.

São muito importantes, e quando somados a medicação potencializam o tratamento.

#### **▼ Medidas farmacológicas**

Devemos sempre começar com doses baixas e ir aumentando lentamente.

Fase de latência de 4 a 8 semanas para a medicação atingir o efeito máximo, e ao chegar na dose máxima, se ainda tiver sintomas residuais, precisamos ajustar a medicação.

Explicar possíveis efeitos colaterais.

Em casos de 1º episódio depressivo podemos manter o tratamento por 1 ano e retiramos gradualmente (desmame). Paciente com episódios depressivos anteriores podemos manter por mais tempo, cerca de 2-3 anos. Mas em pacientes graves o tratamento é para o resto da vida.

#### ▼ **Tricíclicos**

Menos usados, pelos grandes efeitos colaterais como confusão mental, delírio, hipotensão ortostática, boca seca.

Mas se não houver escolha, podem ser usados em menores doses associado com outros antidepressivos.

**Ação:** bloqueiam a recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina.

**Exemplo:** Imipramina, amitriptilina, clomipramina, nortriptilina.

#### ▼ **Inibidores seletivos da recaptação da serotonina**

**Exemplo:** Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina.

Fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina interagem com citocromo P450, ou seja, interagem com outras medicações, então não usamos muito.

#### **Efeitos colaterais:**

- Cefaléia;
- Náuseas;
- Hiponatremia: se usam diuréticos, tem IC, devemos cuidar muito com o risco de hiponatremia;
- Hemorragia digestiva: antetar-se ao uso de antiagregantes plaquetários, anticoagulantes.

Podem melhorar os sintomas de humor e pode apresentar resposta apática.

- Fluoxetina deve ser evitada no idoso devido a meia vida longa e maior SIADH;
- Paroxetina tem efeito anticolinérgico, sedativo e hipotensão postural;

- Citalopram é o mais seletivo na recaptação da serotonina, conforme aumenta a dose do medicamento, aumenta o risco de aumento do intervalo QT, por isso não devemos passar de 20 mg;
- Escitalopram tem pouca interação medicamentosa, deve ser evitado em pacientes com convulsões, cardiopatia isquêmica, risco de hiponatremia e hemorragia digestiva. Não devemos passar de 10 mg pelo risco de prolongar o intervalo QT;
- Sertralina é a medicação de escolha para pacientes com cardiopatia isquêmica, HAS e arritmias. Menor risco de efeitos adversos e conseguimos chegar na dose máxima de 150 mg com mais segurança.

#### ▼ Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e norepinefrina

Exemplo: venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina.

- Duloxetina deve ser indicado em pacientes com dor crônica e IU de urgência;
- Venlafaxina: tem efeito mais rápido, é a mais potente, devemos ter cuidado nos pacientes hipertensos (não prescrevemos em HAS não controlada);
- Desvenlafaxina: doses maiores esta associado com HAS e dislipidemia. Mais utilizado em depressões leve/moderadas.

#### ▼ Inibidores seletivos de norepinefrina e dopamina

Exemplo: Bupropiona.

Associado a outra classe de medicamentos e em pacientes com Parkinson. Com risco de HAS, parestesias e tonturas. Mais usado em depressões refratárias e muito apáticas.

#### ▼ Dupla ação serotoninérgica e noradrenérgica por meio antagonismo alfa-2

**Ação:** antagonista em receptores alfa-2 pré-sinápticos dos neurônios serotoninérgicos e noradrenérgicos.

Causa sedação pelo bloqueio 5HT<sub>2A</sub> e de H<sub>1</sub> (muito bem indicada em insônia + depressão), e ganho de peso (insônia + pouco apetite).



**Exemplo:** Mirtazapina e mianserina.

Obs: até 15 mg tem bom efeito sedativo e aumento do apetite. Em doses maiores, há aumento da atividade noradrenérgica, reduzindo a sedação relativa.

#### ▼ **Antagonistas de dupla ação em receptores serotonina e inibição da recaptação de serotonina**

Exemplo: Trazodona e nefazodona.

- Trazodona tem efeito sedativo pois bloqueia H1. Podendo ser usada de 50-100 mg para insônia e para tratamento antidepressivo geralmente é >150 mg.

Cuidado em pacientes com arritmias e convulsões, pois reduz o limiar de convulsão.

#### ▼ **Agonistas de receptores melatoninérgicos MT1 e MT2 e antagonistas serotoninérgicos. dos receptores**

Exemplo: Agomelatina, indicada para sintomas depressivos e insônia.

Deve ser evitada em idosos com déficit cognitivo e maiores de 75 anos e devemos monitorar enzimas hepáticas.

#### ▼ **Vortioxetina**

Tem ação multimodal, agindo em serotonina, dopamina, norepinefrina, glutamato, gaba, histamina e sistemas colinérgicos.

Indicado em depressão com várias comorbidades, risco de hiponatremia ou sintomas cognitivos. Bem tolerado.

#### ▼ **Eletroconvulsoterapia**

Tratamento efetivo 60 a 80% de eficácia, indicado para pacientes graves, alto risco de suicídio, manifestações catatônicas ou psicóticas, necessidade de resposta rápida, desnutrição por recusa alimentar e depressão recorrente.

Efeitos colaterais: delirium e déficits de memória.

Geralmente são feitas 6-8 sessões. O paciente é sedado e são feitos choques na região temporal. As medicações devem ser continuadas.

#### ▼ **Estimulação magnética transcraniana**

Estimulação do lobo frontal, por neuroestimulação superficial e focal, aumentando a quantidade de neurotransmissores, com resultados encorajadores. • Requer mais estudos

#### ▼ **Tratamento depressão resistente**

Podemos realizar mudança de antidepressivo ou associar antidepressivos como venlafaxina e mirtazapina, associar tricíclico e bupropiona.

Podemos associar antipsicóticos como aripiprazol, quetiapina e risperidona. Associar lamotrigina, lítio, modafinila, escetamina, mas geralmente em depressões mais graves.